

Le 04 Juillet 2023

Cocher la ou les réponses justes :

- 1- Les étiologies des avortements du premier trimestre de la grossesse :
 - a- La béance cervico isthmique
 - ☒ b- Les aberrations chromosomiques
 - ☒ c- Les infections urinaires
 - d- Les maladies débilitantes
- 2- Dans les moles hydatiformes :
 - a- Le curetage se fait à l'aide de la petite curette mousse
 - ☒ b- La surveillance s'étale sur 4 mois
 - c- Le taux des beta-HCG est très élevé
 - d- Le curetage se fait sous contrôle échographique
- 3- Le Test Post Coïtal fait chez un couple hypofertile de 5 mois est considéré normal si :
 - a- 10 spermatozoïdes actifs par champs au grossissement G400
 - b- 5 spermatozoïdes actifs par champs au grossissement G400
 - c- Pas de spermatozoïdes au grossissement G200
 - ☒ d- Spermatozoïdes mobiles actifs sous microscope électronique
- 4- Hystérosalpingographie est :
 - a- Demandé devant une infertilité de plus de 1 an
 - ☒ b- Se fait entre le 8 -ème et le 10ème jour du cycle menstruel
 - ☒ c- Sous anesthésie générale
 - d- Demandé devant une infertilité de moins de 5 mois
- 5- La contraception hormonale oestroprogestative :
 - ☒ a- Débuter le 5 -ème jour du cycle menstruel
 - b- Est prise sans interruption
 - c- Est contre indiqué en cas d'utérus cicatriciel
 - d- Débuter le 1er jour du premier cycle menstruel
- 6- Dans quelles situations vous administrer l'anti-D :
 - a- Femme de rhésus négatif mari rhésus négatif opéré pour GEU
 - b- Femme de rhésus négatif mari rhésus positif accouche d'un enfant rhésus négatif test de Coombs direct positif
 - ☒ c- Femme de rhésus négatif mari de rhésus positif enfant mort ne de rhésus positif test de Coombs direct négatif
 - ☒ d- Femme de rhésus négatif qui avorte au 1er trimestre sans curetage et mari rhésus positif
- 7- La présentation du front :
 - ~~a- Est une présentation totalement défléchie~~
 - ☒ b- Est une présentation dystocique
 - ☒ c- L'enclavement est la complication la plus redoutable
 - ☒ d- Le menton n'est jamais perçu
- 8- La délivrance normale :
 - a- Se fait dans un délai de 1 heure
 - ☒ b- Le mode Baudelocque représente l'expulsion du placenta par la face fœtale lisse

- c- Le phénomène passif correspond à la reprise des contractions utérines après un repos de 10 à 15 mn
- ☒ d- La vacuité et l'intégrité utérine est l'une des principales conditions d'une bonne hémostase
- 9- L'hémorragie de la délivrance :
- a- Elle est définie par une hémorragie supérieure à 1 litre pour un accouchement par voie basse
- ☒ b- Le traitement repose sur l'hystérectomie d'hémostase
- c- Il faut faire une traction sur le cordon pour aider à l'expulsion du placenta
- ☒ d- Le respect de la physiologie de la délivrance est l'un des moyens de prévention
- 10- La grossesse diabétique :
- ☒ a- Est une grossesse à haut risque materno-fœtal
- ☒ b- Le risque de malformation fœtale est important en cas de diabète type 1 ou 2 déséquilibrés avec hémoglobine glyquée supérieur à 7
- c- Les antidiabétiques oraux sont maintenus tout au long de la grossesse
- d- L'accouchement se fait systématiquement par césarienne prophylactique
- 11- Dans la classification échographique des fibromes utérins :
- a- Les fibromes avec une composante intra-cavitaire sont de type 0, 1, 2
- b- Les fibromes pédiculés sont de type 0 et 6.
- c- Les fibromes intra-muraux sont de type 4 et 5.
- ☒ d- L'échographie est suffisante pour faire le diagnostic des fibromes, leurs tailles, leurs nombres et leurs localisations.
- 12- L'accouchement d'une présentation de face est caractérisé par :
- ☒ a- Une dilatation trainante du col utérin.
- b- La rupture de la poche des eaux avant la phase active du travail est un bon signe.
- ☒ c- La surveillance du travail est obligatoire en salle d'accouchement.
- d- Le diagnostic est posé dès la dilatation de 3 cm.
- 13- Dans l'hypertension artérielle :
- ☒ a- Le problème est lié à un défaut de placentation et l'absence de remodelage vasculaire durant la période allant de 14 sa à 20sa.
- b- Ce problème peut être détecté échographiquement par une diminution des résistances au doppler des artères utérines.
- c- L'ischémie placentaire est secondaire au micro-thromboses, et elle responsable de la libération des substances vasoconstrictrices.
- d- La découverte de l'HTA au premier trimestre impose l'interruption thérapeutique de grossesse.
- 14- Dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, la prise en charge repose sur :
- ☒ a- L'introduction se fait dès le premier pic tensionnel détecté à la consultation.
- b- On commence toujours par un inhibiteur central (aldomet) sous réserve d'un bilan hépatique correct.
- ☒ c- Régime sans sel.
- d- Le sulfate de magnésium est réservé pour les signes de pré éclampsie.
- 15- L'adénocarcinome utérin :
- ☒ a- C'est un processus tumoral dont le pronostic est mauvais par rapport au sarcome utérin.
- b- Le diagnostic est confirmé à l'IRM.
- c- Le type histologique bien différencié est de mauvais pronostic.
- ☒ d- Le traitement est chirurgical radical chaque fois que possible.
- 16- Quel est l'examen à demander devant un saignement génital survenu chez une femme âgée de 55ans avec un épaissement de l'endomètre à l'échographie :
- a- IRM
- b- Scanner

☒ c- Hystérocopie diagnostic

☒ d- Hystérosalpingographie.

17- Dans la situation d'incompatibilité :

☒ a- La femme est de rhésus négatif/ fœtus de rhésus positif.

☒ b- L'anémie fœtale arrive au troisième stade du tableau d'anasarque fœto-placentaire.

c- Le recours à la transfusion in utero est toujours systématique.

d- Le pronostic fœtal est toujours sombre et l'interruption de la grossesse toujours s'impose au premier stade du tableau d'anasarque fœto placentaire.

18- Selon la classification FIGO du cancer de l'ovaire, un cancer classé IIb :

a- Atteinte d'un ovaire ou des deux et atteinte de l'utérus ou de la trompe

b- Les deux ovaires sont atteints, avec absence de rupture capsulaire

c- Atteinte d'un ovaire ou les deux, et extension au reste du pelvis

☒ d- Atteinte d'un ovaire ou les deux, avec absence d'extension au reste du pelvis

19- Quelles sont les causes où l'on pourra retrouver à un test au progestatif négatif :

☒ a- Une ménopause précoce

b- Un syndrome des ovaires polykystique

c- Une synéchie utérine

d- Une hypoplasie ovarienne

20- Le dépistage du cancer de l'ovaire se fait par :

☒ a- Réaliser le dosage de CA125 tous les deux ans chez les femmes ménopausées

b- Réaliser des échographies pelviennes chaque année à partir de 30 ans

c- Il n'y a aucun moyen de dépistage

d- Réaliser des échographies pelviennes avec le dosage du CA125 tous les deux ans à partir de 25 ans

21- Dans les variétés OPID de la présentation du sommet on observe souvent :

a- Une bosse séro-sanguine importante

b- Un engagement plus rapide du fœtus de l'asynclitisme

c- Une dilatation trainante

☒ d- Une rotation de 45° en avant

22- Parmi les étiologies de l'hémorragie du troisième trimestre, on note :

☒ a- Un placenta prævia

b- Une rupture utérine

☒ c- Une menace d'accouchement prématuré

d- Un hématome retro placentaire

23- Les contractions de travail sont :

☒ a- Douleuruse, rythmées, involontaires et totales.

☒ b- Elles sont responsables de la dilatation du col et la formation de la poche des eaux.

c- Elles sont permanentes sans un temps de relâchement.

d- Elles surviennent juste au terme de la grossesse.

24- L'échographie du 1^{er} trimestre :

☒ a- Est une échographie de datation.

☒ b- Permet d'éliminer une grossesse extra utérine.

c- Permet d'apprécier la vitalité du fœtus.

d- Détermine le sexe du fœtus.

25- Chez une gestante avec un placenta prævia diagnostiqué au troisième trimestre de la grossesse asymptomatique :

a- Le pronostic maternel est toujours sombre.

☒ b- Le diagnostic est confirmé à l'échographie et le placenta est classé selon la classification Bessis.

☒ c- Dans Les variétés latérales l'accouchement par voie basse peut être autorisé.

(d) Le mode et moment d'accouchement sont en fonction de l'état materno-fœtal.

26- Le placenta prævia :

a- Le toucher vaginal est proscrit

(b) Peut-être à l'origine d'une présentation dystocique

(c) La césarienne est indiquée d'emblée devant un placenta prævia

d- Peut se compliquer d'une hémorragie de la délivrance

27- La rupture utérine en cas d'utérus sain :

a- On trouve un utérus déformé en sablier

b- L'anneau de BANDEL est un anneau de rétractation séparent le segment inférieur aminci du corps utérin rétracté

c- Les bruits du cœur fœtal sont toujours présents

(d) Le traitement repose sur la chirurgie et les mesures de réanimation

28- La menace d'accouchement prématuré est :

(a) La première cause de mortalité et de morbidité néonatale

(b) Est caractérisée par la survenue de Contractions utérines rapprochées sans modification cervicale

c- La menace aboutie à un accouchement prématuré en l'absence d'un traitement médical

d- Le diagnostic est surtout clinique.

29- La rupture prématurée des membranes :

(a) Est un facteur de risque d'endométrite du poste partum

b- La rupture est dite prématurée lorsqu'elle se rompt au cours du travail

c- L'œuf s'expose à l'infections d'autant plus que le travail tarde

d- Elle peut se compliquer d'une chorioamniotite.

30- Parmi les caractéristiques de l'endométriose :

a- Présence de nodosité bleuâtre au niveau de l'utérus à l'exploration coelioscopique

(b) Présence d'un liquide chocolat au niveau de l'endométriose

(c) Les adhérences pelviennes sont très fréquentes

(d) ATCD d'endométriose dans la famille peut être un facteur de risque



Gynécologie - Obstétrique, programme d'examen 'Rattrapage Théorique', de la : Cinquième Médecine

Date de l'examen : 20/07/2022

Corrigé Type

Barème par question : 0,333333

N°	Rép.
1	BCD
2	CD
3	B
4	AB
5	D
6	CD
7	BCD
8	BO
9	D
10	AB
11	ACD
12	AC
13	AC
14	BO
15	D
16	C
17	A
18	C
19	ACD
20	C
21	AC
22	ABCD
23	AB
24	ABC
25	BCD
26	ABD
27	ABD
28	ACD
29	ACD
30	ABCD
31	
32	

N°	Rép.
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	